

RESUMEN PSIQUIATRÍA

Dr. Guillermo Guevara

I. TRASTORNOS DEL ÁNIMO

También se llaman trastornos anímicos o trastornos afectivos. Los más importantes son la depresión y el trastorno afectivo bipolar (TAB).

1. Depresión

Es una patología muy frecuente en Chile (en algunos estudios es la patología psiquiátrica más frecuente).

Clínica: se caracteriza por ánimo bajo o triste, anhedonia (no siente placer con las cosas que habitualmente le generaban), además de afectación en múltiples áreas de la vida, tales como alteraciones del peso (baja de peso es lo más frecuente), alteraciones del sueño (insomnio es lo más frecuente), dificultades en la concentración, afectación de la vida sexual, sentimientos de inutilidad e ideas de muerte. En los casos más grave puede existir ideación suicida e incluso intentos de suicidio.

Los síntomas deben estar presentes por al menos 14 días y siempre debe tener tristeza y/o anhedonia, más algunos de los otros síntomas. En el adulto mayor puede simular una demencia.

Existen algunos tipos de depresión que vale la pena mencionar:

- Depresión melancólica: Es la clásica depresión ya descrita.
- Depresión atípica: Se caracteriza por subir de peso y presentar hipersonmnia. Además, presenta "craving" por dulces y chocolates y angustia de predominio matinal. Finalmente tiene intolerancia al rechazo.
- Depresión psicótica: Además de los síntomas anímicos, tiene un delirio (pérdida de juicio de realidad), siendo los más frecuentes el delirio de culpa (se culpa y siente responsable de algo que obviamente no es culpa suya, ej. la muerte de alguien), el delirio de ruina (no ve solución a sus problemas, los que siente muy graves) y el delirio de enfermedad (cree estar enfermo de una enfermedad grave o incurable, incluso puede llegar a creer estar muerto). Para diferenciarla de otros trastornos psicóticos, es importante ver que predominan los síntomas depresivos y que solo al final aparece el delirio.
- Depresión doble: Es aquella en la que previamente tenía una distimia (o depresión menor) y que luego se agrega una depresión (o depresión mayor).
- Depresión reactiva: Es aquella que tiene un claro gatillante (ej. la muerte de un ser querido, el fin de una relación o perder el trabajo). Suele confundirse con el trastorno adaptativo, pero este es más leve y no cumple criterios de depresión. Es la causa más frecuente del primer episodio depresivo.
- Depresión bipolar: Es la que se da en contexto de un paciente con trastorno bipolar. También debe sospecharse en quien no ha sido diagnosticado de trastorno bipolar, pero tiene historia familiar de dicha enfermedad o una depresión muy severa a temprana edad sin un gatillante. Su manejo es totalmente distinto (se verá más adelante).

El tratamiento general consiste en psicoterapia más tratamiento farmacológico con antidepresivos. Aunque todas las familias de antidepresivos tienen eficacias similares, actualmente, los de elección son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (se abrevian como IRS o ISRS), que incluyen a la fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram y sertralina. Tienen menores efectos adversos que los antidepresivos tricíclicos (amitriptilina,

nortriptilina, Imipramina, clomipramina) e IMAOs (inhibidores de la monoamino oxidasa: fenelcina, seleginina, moclobemida). Además, tienen un menor costo que los antidepresivos duales (venlafaxina, duloxetina, mirtazapina, bupropión, etc.).

Es importante recordar que **el tratamiento antidepresivo no tiene efecto inmediato** y suele comenzar a mejorar el ánimo luego de 2 a 3 semanas. De hecho, solo se considera que falló el tratamiento, luego de 4 a 6 semanas sin presentar mejoría (4 semanas si no hay ninguna mejoría o empeora y 6 semanas si la mejoría es muy escasa). El tratamiento farmacológico se mantiene mínimo por 6 meses después de haber logrado la completa remisión de los síntomas.

Al retirar los IRS, se puede producir un síndrome de discontinuación de los IRS, que se caracteriza por síntomas ansiosos y similares a una infección respiratoria ("flu like"), que dura unos pocos días. Por eso, se recomienda educar al paciente y bajar la dosis a la mitad, por una semana, antes de suspenderlos.

Algunos detalles del tratamiento:

- En los niños se prefiere la psicoterapia sola, con enfoque sistémico o familiar, sin fármacos. Sin embargo, los fármacos son una opción aceptable como primera, en específico, fluoxetina. Si no responde, se recomienda cambiar a otro IRS, en especial, sertralina o citalopram. Los antidepresivos duales, como venlafaxina, duloxetina o bupropión aparecen como tercera línea (en adultos es segunda línea). También se debe indicar por mínimo 6 meses desde que remiten los síntomas.
- En el embarazo, el fármaco de elección es la fluoxetina o la sertralina (tienen más estudios de seguridad) y en la depresión postparto es de elección la sertralina (pasa menos a la leche materna). En la práctica, se indica sertralina en el embarazo, para no tener que cambiar el antidepresivo después del parto.
- En el adulto mayor están contraindicados los antidepresivos tricíclicos y se debe optar por IRS, en especial la sertralina, el citalopram o el escitalopram, que son los IRS con menos interacciones medicamentosas. La paroxetina ha caído en desuso, por tener mayor tasa de efectos adversos.
- La depresión atípica históricamente se ha tratado con antidepresivos IMAOs, ya que demostraron ser mejores que los tricíclicos antes de que existieran los IRS. Sin embargo, actualmente se recomienda partir con IRS, dado su mejor perfil de seguridad y cambiarse a IMAOs, solo si no funciona.
- En la depresión psicótica se debe agregar antipsicóticos atípicos (ej. quetiapina o risperidona).
- En la depresión bipolar están contraindicados los antidepresivos y se suele tratar con antipsicóticos y estabilizadores del ánimo.
- En las depresiones que no responden a IRS, luego de 4 a 6 semanas, se cambia el tratamiento a antidepresivos duales o nóveles, en especial la venlafaxina y duloxetina, que actúan inhibiendo la recaptura de serotonina y noradrenalina. También se usa la mirtazapina, que tiene un mecanismo de acción algo diferente sobre los mismos neurotransmisores. Finalmente, el bupropión actúa inhibiendo la recaptura de noradrenalina y dopamina.
- En los casos en que los IRS producen efectos adversos también se cambia a antidepresivos duales. Si los efectos adversos, en específico, están relacionados con la vida sexual, se prefiere la mirtazapina, ya que no tiene efecto negativo en la actividad sexual.
- Los casos muy graves y refractarios, así como la depresión psicótica severa (en especial en adultos mayores y embarazadas) se puede tratar con terapia electroconvulsiva (TEC), con buena respuesta.

2. Distimia

Clínicamente se presenta como tristeza y disforia la mayor parte del tiempo, sin cumplir criterios de depresión, por un tiempo de, al menos, 2 años (1 año en niños y adolescentes). Se trata de una persona que no es feliz por largo tiempo, aunque su ánimo puede mejorar transitoriamente por algunos días o semanas.

La importancia de diagnosticarla consiste en que, aunque no cumpla criterios de depresión, por lo prolongado de sus síntomas, se debe tratar igual a una depresión mayor.

3. Trastorno bipolar o trastorno afectivo bipolar (TAB)

Es una enfermedad genética, autosómica dominante con penetrancia incompleta, que se caracteriza por la presencia de al menos un episodio maniaco, hipomaniaco o mixto. Sin embargo, es importante aclarar que también cursa con episodios depresivos y que estos son más frecuentes que los otros. La importancia de saber identificarlo es que 1. Suele ser catastrófico desde el punto de vista personal y económico, cuando no es bien tratado. Por el contrario, con un adecuado tratamiento puede lograr una completa funcionalidad y 2. La depresión bipolar se trata de manera muy diferente a la depresión unipolar.

El episodio maniaco (o manía) se caracteriza por un ánimo eufórico y elevado, muchas veces expansivo, pero también irritable, con verborrea, fuga de ideas (pasa rápido de un tema a otro, dejando ideas inconclusas), disminución de los requerimientos de sueño (no necesita dormir). Además, es frecuente que gasten mucho dinero, cometan muchos errores, tengan ideas de grandeza, estén irritables y peleen con familiares y otras personas. En los cuadros más graves puede volverse psicótico, agregándose un delirio, por lo general de tipo paranoide o megalomaniaco (de grandeza). Los síntomas deben estar presentes por al menos 4 días (no se debe esperar mucho para diagnosticar el episodio agudo).

El episodio hipomaniaco (o hipomanía) es similar, pero mucho más leve.

El episodio mixto tiene simultáneamente síntomas de manía y de depresión. Tiene alto riesgo de suicidio.

Solía llamarse TAB tipo I al que presenta manías, tipo II al que presenta hipomanías y tipo III al que fue desencadenado por fármacos (antidepresivos, corticoides, metilfenidato, drogas, etc). Sin embargo, actualmente se cree que son una misma enfermedad.

Es muy importante diferenciarlo de una depresión (unipolar), ya que en el trastorno bipolar están absolutamente contraindicados todos los antidepresivos, dado que pueden descompensar al paciente y "hacerlo virar" a una manía. De hecho, en toda depresión se debe preguntar por episodios previos que puedan ser una manía/hipomanía y por los antecedentes familiares. Además, si un paciente deprimido inicia antidepresivos y "vira" es obligatorio suspender el tratamiento y ajustarlo al de un TAB.

El **tratamiento** del TAB ha cambiado en el último tiempo, ya que los antipsicóticos han demostrado ser buenos estabilizadores del ánimo (en especial, aripiprazol, risperidona, quetiapina y olanzapina). El tratamiento se puede resumir en lo siguiente:

- i. Lo primero y más importante es que están contraindicados todos los antidepresivos.
- ii. El episodio agudo se trata con litio, anticonvulsivantes y/o antipsicóticos.
 - **Manía aguda** (2 fármacos): idealmente litio más antipsicótico.
 - Aceptable valproato o carbamacepina más antipsicótico.
 - Si está agitado y agresivo, de elección, haloperidol e incluso se puede mezclar con lorazepam.
 - Si falla, se cambia el litio o el ácido valproico, por el otro fármaco.
 - Si falla nuevamente, se cambia el antipsicótico (hasta dos veces).
 - De última línea, se indica TEC (terapia electroconvulsiva).
 - **Hipomanía** (1 fármaco): actualmente se recomiendan más los antipsicóticos que el litio o anticonvulsivantes, aunque cualquiera es una opción aceptable. Si falla, se trata como una manía.
 - **Episodios mixtos y cicladores rápidos** (4 o más episodios en un año) actualmente se tratan igual que la manía (litio o valproato más antipsicótico).
 - **Depresión bipolar** (1 fármaco): actualmente se recomiendan los antipsicóticos, en especial, quetiapina y la lurasidona. Recordar que los antidepresivos están contraindicados. Segunda línea: otros estabilizadores del ánimo. Si el riesgo de suicidio es muy alto o está psicótico, considerar TEC.
- iii. Luego se indica terapia de mantención a permanencia: idealmente los mismos fármacos que lograron la remisión. Se cambian, si fallan. La lamotrigina se puede usar para prevenir nuevos episodios, pero no parece útil en el cuadro agudo.

4. Trastorno adaptativo

Se caracteriza por síntomas depresivos y/o ansiosos (se clasifica en tipo depresivo, ansioso y mixto, según los síntomas que predominen), que aparecen después de un desencadenante claro (muerte de ser querido, despido, divorcio, partida de hijos, estrés por deudas, enfermedades, cambios de casa, etc.) y sin cumplir criterios de depresión ni de trastornos ansiosos, por tanto, es un diagnóstico de descarte.

Puede tener ánimo bajo, irritabilidad, algún grado de anhedonia, pero, habitualmente no tiene variaciones en el peso, ni en el sueño y el paciente tiene esperanza de que el problema se solucione. Generalmente no tiene crisis de pánico, pero sí puede tener preocupación, insomnio e incluso sensación de opresión torácica y síntomas somáticos. Además, puede tener conductas desadaptativas, como consumo de alcohol o descuido del aspecto personal.

Dado que es una patología leve, el tratamiento es solo con psicoterapia (enfocada en ayudarlo a superar la crisis, que se suele llamar “psicoterapia de conversación”), por lo que es importante distinguirlo de las otras patologías.

II. TRASTORNOS ANSIOSOS

Son un conjunto de trastornos, cuyo síntoma principal es la ansiedad, preocupación, miedo o angustia (todas son la misma emoción).

En los momentos de angustia muy intensa, se puede producir una crisis de angustia o crisis de pánico, caracterizada por aparición rápida de miedo, angustia, llanto y una infinidad de síntomas (disnea, palpitaciones, opresión precordial, vértigo, náuseas, parestesias, miedo a morir, sensación de muerte, ganas de salir corriendo, visión borrosa, debilidad, sudoración, lipotimias, etc.). Las crisis de pánico son un síntoma de estos trastornos; no son una enfermedad en sí.

El tratamiento de todos los trastornos ansiosos es con psicoterapia y/o antidepresivos IRS. Si no hay buen acceso psicoterapia, se debe tratar solo con fármacos. En cambio, si la psicoterapia está disponible, se recomienda indicarla ya sea con fármacos o sin ella.

- Los IRS se inician con dosis bajas (ej. la mitad de la dosis), las que se van subiendo lentamente, hasta alcanzar la dosis habitual a las 2-3 semanas, porque pueden tener un efecto ansiogénico al inicio.
- Además, se pueden dar benzodiacepinas, como tratamiento sintomático en los cuadros graves, en especial al inicio, pero luego debe ir bajándose la dosis hasta retirarse en 2-4 semanas.
- Las crisis de pánico se tratan sintomáticamente, con benzodiacepinas de rápida acción (ej. Lorazepam sublingual o endovenoso).
- En niños idealmente se tratan solo con psicoterapia. En casos muy graves o refractarios, se indican los IRS, evitando otros fármacos (ej. benzodiacepinas).

1. Trastorno de pánico, ansiedad o angustia

Se lo puede llamar indistintamente como “trastorno de pánico”, “trastorno de ansiedad” o “trastorno de angustia” y no debe ser confundido con el “trastorno de angustia generalizada”.

Se caracteriza por presentar crisis de pánico inesperadas y recurrentes, sin un desencadenante claro (aunque sí puede tener múltiples estresores o atribuir la crisis a algún evento específico). Es muy frecuente, además, la ansiedad anticipatoria (miedo a presentar la crisis y sufrir un problema grave durante ella). Además, suele asociarse a agorafobia y de hecho se clasifica en "con" y "sin" agorafobia, sin embargo, no debe confundirse con la agorafobia sola (aunque se traten igual).

Tampoco se debe confundir la crisis de pánico (es un síntoma y puede estar en otras patologías), con el trastorno de pánico (es una enfermedad caracterizada por tener crisis de pánico).

Finalmente, se deben solicitar siempre niveles TSH y un EKG para descartar hipertiroidismo y arritmias que puedan simular las crisis de pánico. La hipoglicemia también puede simular una crisis de angustia.

2. Trastorno de angustia generalizada / ansiedad generalizada

Su síntoma principal es la expectación ansiosa, es decir, el paciente espera con ansiedad a que algo malo le ocurra a él o a sus seres queridos (asalto, enfermedad, accidente, etc.). En otras palabras, tiene múltiples preocupaciones de distinta índole, que suelen resumir en “miedo a todo”, pero también en “miedo a nada en concreto”, ya que las preocupaciones son demasiadas.

Además, tiene muchas conductas evitativas, por lo que limita sus actividades normales, por miedo a que algo malo le pueda suceder durante ellas. Generalmente no tiene crisis de pánico, por lo que no se confunde fácilmente con el trastorno de angustia o de pánico, sino con otras patologías, en las que se restringe su vida (ej. no sale de su casa), tales como agorafobia o depresión.

El tratamiento es el general de los trastornos ansiosos, ya descritos.

3. Trastorno de estrés postraumático

Siempre sucede luego de un evento traumático que el paciente percibe como amenazante para su vida o integridad física o para la de los demás (ej. un accidente de tránsito, un incendio, un terremoto, incluso ver como atropellan a un animal). Se caracteriza por reexperimentación (pesadillas y recuerdos vívidos), evitación, hiperalerta (se sobresalta y angustia con pequeños estímulos) y embotamiento afectivo (no puede expresar ni identificar claramente sus emociones). Los síntomas están presentes después de 4 semanas después del evento gatillante.

El tratamiento consiste en psicoterapia especializada en trauma y/o antidepresivos IRS. Es decir, el tratamiento general de los trastornos ansiosos.

4. Trastorno de estrés agudo

Es idéntico al anterior, pero cuando aún no han pasado 4 semanas desde el evento. La diferencia es importante, ya que no se utilizan fármacos y en que el tratamiento solo requiere psicoterapia de contención emocional. A lo más, se pueden indicar dosis bajas de benzodiazepinas, como tratamiento sintomático.

5. Trastorno obsesivo compulsivo

Se caracteriza por la presencia de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son ideas recurrentes, "parasitarias", desagradables, que generan angustia. Las compulsiones en cambio son acciones que disipan la angustia y que suelen estar relacionadas a la obsesión.

Las obsesiones y compulsiones más frecuentes son: 1. contaminación y limpieza y 2. duda y corroboración (ej. la casa quedó abierta y regresa a cerrarla nuevamente), pero pueden ser de cualquier tipo (ej. siente que se va a deformar su cara y se mira en el espejo; ej. 2 siente que puede ser un depravado y reza para no serlo).

En ocasiones es posible identificar solo la compulsión o solo la obsesión, pero, probablemente se trata de un trastorno obsesivo compulsivo, en el que la compulsión es un acto mental (ej. pensaren cosas buenas) o en los que la obsesión se mantiene en reserva o no ha sido identificada (Ej. se persigna muchas veces, pero no dice por qué).

El tratamiento del TOC incluye psicoterapia (generalmente cognitivo conductual de exposición y prevención de respuesta) y/o antidepresivos IRS (al igual que todos los trastornos ansiosos). El sí, los IRS suelen requerir una dosis relativamente alta (ej. fluoxetina 40 a 80 mg/día). Como alternativas, sirve la clomipramina (tricíclico) y la venlafaxina (dual), ambos también con efectos sobre la serotonina (inhiben recaptura de serotonina y norepinefrina). En los casos refractarios,

se puede agregar una dosis baja de antipsicóticos atípicos (ej. risperidona o quetiapina), ya que tienen un efecto anti impulsivo.

Se asocia al trastorno de personalidad obsesivo compulsivo, pero no debe ser confundido con este. Si bien tienen muchas diferencias, la personalidad obsesiva suele ser egosintónica (no cree tener un problema), mientras que el trastorno obsesivo compulsivo es egodistónico (está incómodo con lo que le está pasando). A modo de ejemplo, si a alguien le encanta su casa muy limpia y ordenada, cree que estar muy limpio es una virtud y piensa que los demás son unos sucios y desordenados, pues, tiene rasgos de personalidad obsesiva compulsiva. En cambio, si se baña diez veces al día, porque lo angustia la idea de estar sucio, en ese caso, tiene un trastorno obsesivo compulsivo.

6. Fobia simple o específica

Es el miedo irracional a algo específico, que puede llegar a producir crisis de pánico, así como otros síntomas ansiosos. También puede presentarse como reacciones vasovagales y lipotimias. Las fobias más frecuentes son a los animales (arañas, serpientes, ratones, perros, gatos, etc) y a la sangre, pero puede ser de cualquier tipo (a volar, a los espacios cerrados, etc).

El tratamiento suele ser psicoterapia de exposición progresiva al agente gatillante. No requiere fármacos.

7. Fobia social

Se caracteriza por angustia ante el escrutinio de los demás, por lo que es frecuente que presente mucha ansiedad e incluso crisis de pánico, en situaciones en las que será evaluado por los demás (exposiciones, exámenes orales), pero también en otras situaciones en que se ve expuesto al juicio de los demás, como comer en público o cantar. Además, suele presentar conductas de evitación ante dichas situaciones. Algunos autores diferencian dos tipos de trastorno por ansiedad social: 1. Ansiedad social generalizada (o simplemente, ansiedad social) y 2. Ansiedad social específica ante performance (suele responder a la psicoterapia sola).

El tratamiento suele ser con psicoterapia específica (ej. exposición a situaciones similares y manejo). En casos más graves, se requieren fármacos: IRS o venlafaxina, al igual que en todos los trastornos ansiosos. Las benzodicepinas pueden ser de utilidad como tratamiento sintomático en momentos específicos, al igual que el propranolol (disminuye palpitaciones y temblor).

8. Agorafobia

Es el miedo irracional a no recibir ayuda (erróneamente se dice que es el miedo a los espacios abiertos, pero el agorafóbico sí puede estar acompañado en los lugares abiertos y evitará lugares cerrados si está solo y le puede pasar algo malo, sin que lo ayuden). Se trata con psicoterapia y/o antidepresivos IRS. Frecuentemente viene asociado al trastorno de angustia.

En la práctica es frecuente confundirlo con el trastorno de ansiedad generalizada, porque ambos tienen conductas evitativas y se limitan sus actividades fuera de su hogar, sin embargo, el TAG tiene múltiples preocupaciones de todo tipo, mientras que la agorafobia se centra en el miedo a que nadie le ayude si le pasa algo malo.

III. TRASTORNOS PSICÓTICOS

La palabra "psicótico" significa "con pérdida del juicio de realidad" y es contraria a la palabra "neurótico".

1. Esquizofrenia

Es una enfermedad genética, autosómica dominante, caracterizada por dificultad para diferenciar la realidad interior (sus propios pensamientos) de la realidad exterior (la realidad). Se caracteriza por presentar síntomas los que se clasifican en negativos y positivos:

- Negativos, primarios o deficitarios: Los más comunes son aplanamiento afectivo, abulia (falta de iniciativa y motivación), apatía, ineficiencia en el trabajo ejecutivo. Son los síntomas que definen a la esquizofrenia, pero son más difíciles de detectar.
- Positivos, secundarios o productivos: Los más comunes son alucinaciones (alteraciones de la percepción, en que perciben cosas que no existen) y los delirios (conjunto de ideas, con pérdida de juicio de realidad). Las alucinaciones de la esquizofrenia son frecuentemente auditivas y personificadas (oyen voces que lo insultan, comentan o le ordenan que haga algo). Por ser más fáciles de identificar, suelen ser la base del diagnóstico. El primer brote suele darse alrededor de los 18 años.

Algunos tipos de esquizofrenia que se deben conocer son:

- Esquizofrenia paranoide: Suele venir asociado a un delirio paranoide o de persecución. Es el tipo más frecuente de esquizofrenia. También puede tener otros tipos de delirios, pero suele ser organizado en torno a un tema.
- Esquizofrenia simple: Solo tiene síntomas negativos y nunca ha presentado delirios ni alucinaciones.
- Esquizofrenia deficitaria: Tiene síntomas negativos muy intensos e invalidantes. Los síntomas positivos pueden estar presentes o ausentes.
- Esquizofrenia residual: Luego de ser tratada con fármacos, mantiene algunos síntomas negativos.
- Esquizofrenia catatónica: Además tiene síntomas motores, como la rigidez cética, mutismo (no habla), estupor catatónico (permanece inmóvil) o movimientos frecuentes.
- Esquizofrenia hebefrénica o desorganizada: Tiene desorganización del pensamiento y del comportamiento. Las alucinaciones y delirios pueden ser totalmente inconexos y difíciles de entender.

El **tratamiento de la esquizofrenia** consiste en antipsicóticos orales de segunda generación más psicoterapia y psicoeducación.

- Generalmente se indica risperidona o aripiprazol en la menor dosis posible, que mantiene al paciente sin síntomas, aunque también sirven la olanzapina y la quetiapina.
- Si responde parcialmente, se debe subir la dosis. Si sigue sin responder, se cambia el antipsicótico.
- Pero, si no adhiere bien al tratamiento, se debe cambiar a un antipsicótico de depósito o larga duración (ej. "Modecate" que es flufenazina de depósito; aunque actualmente la risperidona y el aripiprazol vienen en presentaciones de larga duración).
- Si producen efectos adversos, se debe cambiar a otro antipsicótico. Si vuelve a tener efectos adversos o ideación suicida persistente, se indica la clozapina (tercera línea).

- El tratamiento se debe mantener por mínimo 2 a 3 años, antes de intentar retirarlos cuidadosamente (bajando dosis lentamente y monitorizando los síntomas con frecuencia).
- Los síntomas negativos son muy difíciles de tratar, pero, probablemente responden más a los antipsicóticos atípicos o de segunda generación. La esquizofrenia simple (solo síntomas negativos) o esquizofrenia deficitaria (síntomas negativos muy marcados) suelen tener un pronóstico más pobre.

2. Trastorno delirante crónico

Se caracteriza por la presencia de un delirio sistematizado (bien explicado) por al menos 3 meses (entre 1 y 3 meses, es un T. delirante, pero no crónico). Lo más característico del delirio es la pérdida de juicio de realidad, pero también el carácter fijo y apodíctico, es decir, que el paciente la considera una verdad absoluta, que no admite dudas ni cuestionamientos. Eso sí, es frecuente que al inicio no haya un delirio propiamente tal, sino solo algunas ideas extrañas, las que luego se vuelven delirantes y persistentes.

Por lo general no presenta ni alucinaciones, ni síntomas negativos, lo que lo diferencia de la esquizofrenia. Además, suele presentarse en adultos, siendo frecuente después de los 40 años.

Los delirios más frecuentes son:

- Delirio paranoide: cree que alguien lo persigue, lo espía o bien que hay un complot contra él.
- Delirio erotomaniaco: cree que alguien está enamorado de él.
- Delirio de celos: cree que su pareja le es infiel (puede apoyar su hipótesis en pruebas ridículas, como manchas en las sábanas, etc.).
- Delirio megalomaniaco: cree ser alguien importante y especial o bien cree tener un poder o habilidad especial.
- Delirio de daño: cree que alguien lo odia y hace cosas para dañarlo.
- Delirio de referencia: cree que algo está relacionado con sí mismo, pero no lo está (ej. cree que un terremoto es una señal para él).
- Otros: Puede tener cualquier otro conjunto de ideas, con pérdida de juicio de realidad.

3. Trastorno esquizoafectivo

Se caracteriza por marcados síntomas anímicos (ya sea similar a una depresión o a una manía), más síntomas psicóticos idénticos a una esquizofrenia (delirios, alucinaciones y síntomas negativos). Ambos tipos de síntomas pueden iniciar y desaparecer simultáneamente, o bien, estar presentes en momentos diferentes. Además, tienen un curso crónico y recurrente.

La principal diferencia con la depresión y el trastorno bipolar psicóticos es que en ellos los síntomas psicóticos aparecen al final de un cuadro anímico grave y no necesariamente se parecen a los síntomas psicóticos de la esquizofrenia. También se diferencia de la esquizofrenia complicada con una depresión, en que en la esquizofrenia los síntomas anímicos aparecen al final y no son tan marcados como en el trastorno esquizoafectivo.

El tratamiento consiste en antipsicóticos (tratamiento de la esquizofrenia) más antidepresivos (si es de tipo depresivo) o estabilizadores del ánimo (si es de tipo bipolar). En otras palabras, equivale a tratar la esquizofrenia y la depresión o trastorno bipolar.

IV. TRASTORNOS DE PERSONALIDAD (TP)

Se caracterizan por problemas durante el desarrollo de la personalidad, que hacen que sean personas con problemas para relacionarse con sus pares, ya sea porque no logran desarrollar relaciones interpersonales o porque sus relaciones con los demás son conflictivas.

Se caracterizan por ser egosintónicos, o sea, se sienten bien con sigo mismos y culpan a los demás de los problemas que tienen con ellos.

Se los suele clasificar en 3 grupos o "clusters":

- "Cluster" A (mal llamados "psicóticos", porque no son T. psicóticos): TP esquizoide. TP paranoide. TP esquizotípico.
- "Cluster" B (mal llamados "anímicos", porque no son T. del ánimo): TP narcisista. TP histriónico. TP límite o limítrofe o borderline. TP antisocial.
- "Cluster" C (mal llamados "ansiosos", porque no son T. ansiosos): TP evitativo. TP dependiente. TP obsesivo compulsivo.

Conviene leer los criterios DSM de cada uno, pero, se pueden resumir de la siguiente forma:

- **Esquizoide:** indiferente, afectivamente plano, emocionalmente frío, sin interés en los demás, no le importan los halagos ni las críticas, no tiene amigos y no quiere tenerlos.
- **Paranoide:** desconfiado y celoso. Se enoja fácilmente, ya que se siente atacado.
- **Esquizotípico:** excéntrico, pensamiento mágico, con ideas de referencia (similar a delirio de referencia, pero antes de volverse apodíctico), actitud paranoide, sin amigos íntimos. Hoy se considera una forma de esquizofrenia.
- **Narcisista:** arrogante, se cree especial y único, explota a los demás, poco empático, envidioso y siente que lo envidian, exige reconocimiento, es muy sensible a la crítica y reacciona con enojo. Su autoestima es frágil y depende del reconocimiento de los demás.
- **Histriónico:** demanda atención, preocupado por aspecto, actitud seductora, cree que sus amigos son más cercanos de lo que son, influenciables, dramáticos, inestabilidad emocional.
- **Límite, limítrofe o "borderline":** inestable (en su ánimo, identidad, autopercepción, percepción de los demás, relaciones interpersonales), intenso, impulsivo, agresivo y autoagresivo, lucha contra el abandono, actitudes paranoides.
- **Antisocial:** delincuente, cruel, sin empatía mentiroso, tramposo, manipulador, impulsivo, no mide consecuencias, no siente culpa, se cree superior.
- **Dependiente:** dependiente, indeciso (deja que otros tomen decisiones), no expresa desacuerdo, sensible a la crítica, miedo al abandono, si su relación termina, busca otra.
- **Evitativo:** tímido, se siente inferior, miedo al rechazo, evita exponerse a otros que lo puedan juzgar, no tiene amigos, aunque le encantaría tenerlos. Nota: Algunos autores plantean que hay un continuo con el trastorno por ansiedad social.
- **Obsesivo compulsivo:** inflexible, ordenado, pierde tiempo en detalles (ineficiente), acumulador, crítico con los demás, muy ceñido a las reglas, devoción al trabajo. No confundir con el trastorno obsesivo compulsivo, aunque suelen asociarse.

El tratamiento de todos es la psicoterapia, aunque los del Cluster A suelen tener mal pronóstico, al igual que el trastorno antisocial. Algunos pueden beneficiarse de dosis bajas de antipsicóticos (sirven en impulsividad y en alteraciones perceptuales o cognitivas pre psicóticas) y también sirven los estabilizadores del ánimo (desregulación emocional e impulsividad, especialmente el trastorno limítrofe).

V. TRASTORNOS SOMATOMORFOS

Se caracterizan por presentar síntomas de diversa índole, pero que no tienen una causa orgánica identificable, sino que son de origen psicógeno. El tratamiento consiste en psicoterapia y no requieren fármacos, a menos que se compliquen con otras patologías psiquiátricas, que sí los requieran (suelen complicarse con depresión, pero también suelen ser secundarios a la depresión, por lo que siempre debe evaluarse la presencia de trastornos del ánimo).

Al igual que todas las patologías psiquiátricas, los trastornos somatomorfos suelen agravarse con los periodos de estrés y, en ocasiones, es posible identificar un evento claro, que los desencadena o los agrava.

1. **Trastorno de somatización:** Se caracteriza por tener muchos síntomas, de distinto tipo, sin una patología que los explique. Coexisten múltiples molestias, como cefalea, dolor abdominal, náuseas, prurito, disfagia, disestesias, frialdad, mialgias, síntomas urinarios, etc.
2. **Trastorno por dolor:** Solo presenta un síntoma, el dolor, el que suele estar localizado en alguna zona específica, pero sin una causa orgánica que lo explique. Es posible que previamente haya habido alguna patología que generara el dolor (ej. una herida o fractura), pero actualmente ya no es suficiente para explicar el síntoma (ej. la herida ya cicatrizó bien).
3. **Trastorno por hipocondría:** Se caracteriza por miedo a tener una enfermedad grave o progresiva (ej. cáncer), por lo que solicita múltiples evaluaciones médicas y exámenes. Además, es frecuente que desconfíe de los médicos. A diferencia de los anteriores, por lo general no tiene síntomas, o bien tiene síntomas muy leves, que fácilmente se explican por patologías banales, pero el paciente insiste en que quiere descartar patologías graves. Es importante recalcar que el paciente no pierde el juicio de realidad, a diferencia del delirio de enfermedad (en que está completamente seguro de que tiene una enfermedad).
4. **Trastorno dismórfico corporal:** Se caracteriza por percibir una parte del cuerpo como horrible, lo que afecta su autoestima y lo hace ocultar dicha parte de los demás y buscar cirugía estética u otros procedimientos estéticos. Sin embargo, dicha parte de su cuerpo es normal. El tratamiento del trastorno dismórfico corporal es difícil, pero incluye psicoeducación en el diagnóstico y en la inutilidad de las cirugías plásticas y procedimientos estéticos, ya que tienen altísimas tasas de disconformidad con los resultados de las intervenciones estéticas. También sirven los IRS y/o la psicoterapia.
5. **Trastorno conversivo:** Se caracteriza por síntomas de tipo neurológico, habitualmente de inicio súbito (aunque hay casos más larvados), sin una causa que lo explique. También se llama "histeria" o "trastorno por conversión". Los síntomas más frecuentes son pérdida de conciencia, pérdida de la visión, la audición o la voz, movimientos similares a convulsiones, hemiplejía, imposibilidad de caminar, o de mover alguna extremidad, etc. Suele durar solo algunos minutos/horas y tiene buen pronóstico, en la medida que el paciente acepte el diagnóstico y al manejar el estrés. Es importante asegurarse bien de que no exista una causa orgánica real de base (ej. un accidente cerebrovascular).
6. **Trastorno facticio:** Se caracteriza por fingir y/o autoprovocarse síntomas de cualquier índole, para ganar afecto, cuidados y atención. A diferencia de los demás, el paciente está consciente de que finge, aunque puede no estarlo del todo. Existe un tipo de T.

facticio "por poder", en que el paciente provoca síntomas a otra persona, habitualmente niños o adultos mayores a su cuidado. El síndrome de Münchhausen es aquel T. facticio en que el paciente no solo finge, sino que directamente se provoca lesiones o enfermedades y también puede ser "por poder", sobre un tercero.

7. **Trastorno por simulación:** También finge síntomas o enfermedades, pero con un fin ganancial económico (no afectivo), como obtener pensión de invalidez, licencias médicas, indemnizaciones del algún tipo, aportes de dinero para su mejoría o para evitar algún problema (ej. evitar ir a la cárcel o justificar su inasistencia a la prueba).

VI. TRASTORNOS DISOCIATIVOS

Se presenta en relación a situaciones muy estresantes, ya sea agudas (muerte de alguien, despido, pelea grave) o crónicas (ej. problemas maritales y financieros), en las que se produce una desconexión entre la realidad y el pensamiento del paciente. Suelen ser transitorios y mejoran con psicoterapia o cuando el evento gatillante cesa (no requieren fármacos). Sin embargo, algunos pueden durar mucho tiempo, en especial, la amnesia disociativa.

Los más importantes son:

1. **Amnesia disociativa:** se olvida de lo que pasó. Incluso en ocasiones puede olvidarse de más cosas o inventar una realidad distinta.
2. **Fuga disociativa:** se va del lugar y viaja fuera del hogar o de la ciudad. Suele durar horas, pero puede prolongarse en el tiempo e incluso puede llegar a adoptar otra identidad en el nuevo lugar.
3. **Estupor disociativo:** se queda inmóvil (como "la garrotera" del Chavo del 8).
4. **Despersonalización:** no es un trastorno, sino un síntoma, que consiste en negar que lo que le sucede, le sucede a él, sino que en realidad le está pasando a otro. También puede sentir que su cuerpo no es su cuerpo, sino de otra persona.
5. **Desrealización:** tampoco es un trastorno, sino un síntoma, que consiste en negar que lo que está pasando, está pasando en realidad, sino que se trata de un sueño o algo imposible.
6. **Doble personalidad:** Se discute su existencia. El paciente adquiere más de una personalidad, que no sabe de lo que hace la otra.
7. **Síndrome de Ganser:** es característico de los condenados a muerte y consiste en responder a las preguntas de manera evasiva, evidentemente errónea e inconsistente con lo que se pregunta (pararrespuestas). Pueden tener ideas místicas.

VII. TRASTORNOS DEL DESARROLLO

1. Trastorno del espectro autista (TEA) o condición del espectro autista.

La forma de presentación es muy amplia y variable, pero, en general, se caracteriza por tender a tener 1. Dificultades en el ámbito social (escaso contacto visual, dificultades en la atención conjunta: estar atento a lo mismo que los demás están atentos, corroborando hacia dónde dirigen la mirada los demás, fallan en percibir las reglas sociales implícitas, etc.); 2. Dificultades en el lenguaje (retraso del lenguaje, lenguaje específico y pedante, lenguaje concreto, no entienden el humor de doble sentido ni el lenguaje no verbal); 3. Rigidez cognitiva: dificultades en cambiar el comportamiento y el pensamiento, rituales estrictos, rabietas con los cambios o al salir de la rutina, ideas fijas; 4. Patrón de intereses restringidos (ej. dinosaurios, política, vehículos), a los que dedica mucho tiempo y no siempre son de interés de los demás. Pueden llegar a ser muy sabios en las áreas de su interés; 5. Alteraciones sensoriales (evita que lo toquen, no le gustan las texturas de la comida, camina en punta de pies, porque el piso está frío); 6. Estereotipias y manierismos (movimientos repetitivos, como aleteo, balanceo, aplausos). Se consideran parte de las alteraciones sensoriales, ya que son una forma de autoestimulación; 7. Es frecuente que presenten hiperactividad o se observen como distraídos, lo que puede hacer que se confundan con déficit atencional.

Los hallazgos suelen estar presente desde muy temprano, por lo que, ante la mínima sospecha, se recomienda una adecuada evaluación del desarrollo, ya sea por un profesional entrenado o con test estandarizados (ej. ADOS). Además, permite identificar las áreas específicas a tratar.

El manejo incluye una intervención multidisciplinaria, con neurólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, además de intervención conjunta de la red de apoyo y establecimiento educacional (jardín, colegio). El pronóstico varía según la gravedad de los síntomas y la precocidad de la intervención, por lo que el diagnóstico precoz es fundamental.

De los fármacos, han demostrado alguna utilidad los estimulantes como el metilfenidato, en los casos en que presentan mucha inquietud y dificultades en la concentración y los antipsicóticos, en específico la risperidona y el aripiprazol, en los casos en que tienen conductas agresivas o autoagresivas. Sin embargo, las medidas no farmacológicas son las más importantes.

Algunos autores prefieren la terminología “condición del espectro autista”, en los casos en que tienen una adecuada funcionalidad, ya que se trataría de una forma de ser diferente, propia de la neurodiversidad y no de una patología.

2. Trastorno por déficit atencional (TDA)

Se caracteriza por dos síntomas principales: 1. dificultades en mantener el foco de atención (inatención) y 2. impulsividad con hiperactividad. Eso sí, existe el TDA sin hiperactividad, que suele diagnosticarse más tardíamente. Los síntomas están presentes desde muy temprano, pero el diagnóstico habitualmente se realiza en la etapa escolar, debido a mal rendimiento escolar. Pueden tener dificultades sociales, debido a que la impulsividad puede generar rechazo y a que la falta de atención puede dificultar la adquisición de habilidades sociales. También puede venir aparejada a alteraciones sensoriales.

El tratamiento más importante es multidisciplinario, incluyendo la psicoeducación, psicoterapia cognitivo conductual e intervención educacional, pero, en mayores de 6 años, también suele ser útil apoyar el manejo con estimulantes como el metilfenidato o las anfetaminas.

VII. TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN

1. Anorexia nervosa

Es más frecuente en el sexo femenino y suele empezar en la adolescencia. Se caracteriza por bajo peso, miedo a engordar, alteración de la percepción corporal (se consideran gordas, a pesar de ser flacas) y suelen cursar con amenorrea (por alteraciones hipotalámicas de la secreción de LHRH o GnRH).

Puede ser solamente restrictiva (no ingiere suficiente comida) o bien restrictivo- purgativa (además se induce vómitos, usa laxantes, etc). El bajo peso es una condición que debe estar presente. Se asocia a trastorno de personalidad obsesivo compulsivo y muy rara vez pierde el control sobre la comida.

El tratamiento es multidisciplinario (psicoterapia, nutricionista, etc.) y debe incluir a la familia. En casos muy graves, se suelen agregar antipsicóticos, en especial olanzapina.

2. Bulimia nervosa

Se caracteriza por pérdida del control sobre la comida, con frecuentes atracones (episodios en los que come mucho y rápidamente), frecuentemente seguido de purga (inducción de vómitos, uso de laxantes, ejercicio intenso, etc). Habitualmente tiene peso normal o incluso sobrepeso y se asocia a trastorno limítrofe de personalidad (por la impulsividad y pérdida de control). Sí es frecuente que tengan alteración de la percepción corporal y miedo a engordar.

El tratamiento también es multidisciplinario y tiene mejor pronóstico que la anorexia. La dieta se basa en ordenar la alimentación. Los antidepresivos IRS han demostrado utilidad para manejar los atracones y la ansiedad propia de la bulimia nervosa.

3. Otros.

Existen muchos otros trastornos alimentarios descritos, tales como:

- Trastorno por atracones: solo tiene atracones, pero no purga, lo que lo diferencia de la bulimia.
- Trastorno por evitación y restricción de alimentos: activamente come menos calorías de las recomendadas, pero no tiene una imagen distorsionada de sí mismo, lo que lo diferencia de la anorexia nervosa.
- Trastorno por comer y escupir: no traga, sino que escupe la comida.
- Trastornos por rumiación: regurgita y vuelve a masticar y tragar.
- Síndrome del Gourmet: solo come comida fina y preparada.
- Alcohorexia: deja de comer, para poder consumir alcohol sin engordar.

COMENTARIO FINAL:

Las personas con patologías psiquiátricas pueden llegar a experimentar gran sufrimiento. Como médicos, estamos llamados a acogerlas, tratarlas bien y contribuir a su recuperación. Con un buen tratamiento, pueden llegar a ser felices y ayudar a hacer felices a otros.

Sin embargo, no podemos caer en simplismos y debemos recordar que algunas de estas personas pueden ser muy difíciles de tratar, ser muy demandantes o desgastantes e incluso pueden llegar a ser violentas, ya sea física, verbal o psicológicamente, por lo que también, pueden generar mucho sufrimiento a otros, incluyendo sus propios seres queridos. Por ello, es muy importante abordar este tema en toda su complejidad, desarrollar la paciencia y flexibilidad, pero también establecer límites y saber cómo protegerse.

Entender esta complejidad y estar preparado es la clave para realmente poder acoger, integrar y lograr una sana relación con quienes tienen patologías psiquiátricas, ya sea que se trate de una relación médico paciente o una relación afectiva, laboral o interpersonal de cualquier tipo. De nada sirve levantar consignas de la importancia de la salud mental, la no discriminación y la integración e inclusión, si no somos capaces de darnos cuenta que quien nos cae mal y aislamos, en realidad, tiene una patología psiquiátrica o una condición mental diferente o, si, por tratar de ayudar a alguien sin saber cómo hacerlo, salimos heridos y frustrados.

Finalmente, como médicos, al igual que todos, debemos preocuparnos por nuestra propia salud mental, aprender a identificar y manejar nuestros estresores, saber consultar oportunamente, tener pausas de introspección en las que nos cuestionemos si estamos emocionalmente bien y actuando bien con los demás y, sobre todo, debemos dedicar tiempo y esfuerzos a cultivar una **buena red de apoyo**, buscando ser recíprocos y generosos. Subrayo la red de apoyo porque es la clave de la felicidad y, también, porque no se construye sola, sino que hay que tejlarla y cuidarla.